

Manual de Voo Clínico: parte 2 Anabolizantes e Gestão de Risco

Protocolos, Segurança e Redução de Danos

"Quanto mais deixar a mão no fogo ou quanto mais forte ele for, mais você pode se queimar"

AVISO MÉDICO E LEGAL ABSOLUTO

- * Material estritamente educacional e técnico. NÃO constitui prescrição médica.
- * NÃO incentiva, endossa ou recomenda o uso de AEAs/AAS.
- * Destinado exclusivamente a minimizar a morbidade e mortalidade endócrina, cardíaca e hepática em usuários decididos.
- * Exige profissional habilitado + monitoramento laboratorial rigoroso.

Painel de Protocolos Masculinos (Decisões Baseadas em Risco)

Cenários de Bulking

Jovem / Baixo Risco

Testo 250mg + NPP (volume controlável) + Dianabol (4 sem kick-starter). Monitorar Hct e E2.

Risco Cardiovascular

Testo Baixa (125mg) + Primobolan + Masteron. Zero orais, mínimo impacto lipídico.

Avançado c/ Falta de Appetite

Testo 250mg + Deca + Boldenona (6 sem apenas para fome). Atenção à apatia.

Cenários de Cutting

Base Estética

Testo 250mg + Primo + Masteron. Qualidade máxima, controle integrado de ginecomastia.

Avançado Alopecia/Dislipidemia

Testo Baixa + Primo. Evita Masteron e Oxandrolona.

Elite Pré-Contest

Base + Estanozolol (últimas 4 sem). Requisito: Lipidograma impecável. Se HDL baixo → Turinabol.

Painel de Protocolos Femininos (A Linha Tênu

Virilização)

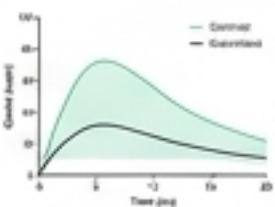


PIRÂMIDE DE VIRILIZAÇÃO: Nandrolona/Stanozolol no TOPO.
STOP imediato ao primeiro sinal de rouquidão, clitoromegalia ou alopecia.

Cenários de Bulking

**Iniciante**

Primobolan 50mg/sem + Oxandrolona 5-10mg (apenas dias de inferiores). Menor exposição sistêmica.



**Avançada**

Primo Base + NPP (10-20mg/sem microdose). Curta meia-vida permite suspensão rápida.



**Dislipidemia Leve**

Primo injetável exclusivo. Protege HDL, evita 17α-alquilados orais.

	Primo	17α	17β	17α	17β
Testosterone	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Testosterone	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Testosterone	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Testosterone	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Testosterone	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Testosterone	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



Cenários de Cutting

**Iniciante**

Primobolan 50mg + Oxandrolona 5mg (apenas dias de treino de pernas).



**Recomposição/Lipídico**

Primobolan 25-50mg + Masteron Microdose. Zero orais.



**Elite Pré-Contest**

Primo + Masteron + Stanozolol (só últimas 3 sem, monitoramento extremo).



Redução de Danos: Mapa Sistêmico (A Rede de Segurança)

Cérebro (Neurobiologia)

Efeitos On/Off Cycle.
Impulsividade, Depressão.
Suporte: Ashwagandha,
5-HTP, Ômega-3.

Safety Net Team

Médico (Manejo) | Farmacêutico (Interações)
| Nutri (Dieta) | Edu. Físico (Carga)

Coração (Hemodinâmica)

Rigidez, ↓HDL. Cardio obrigatório.
Se Hct >52/48% → Flebotomia.

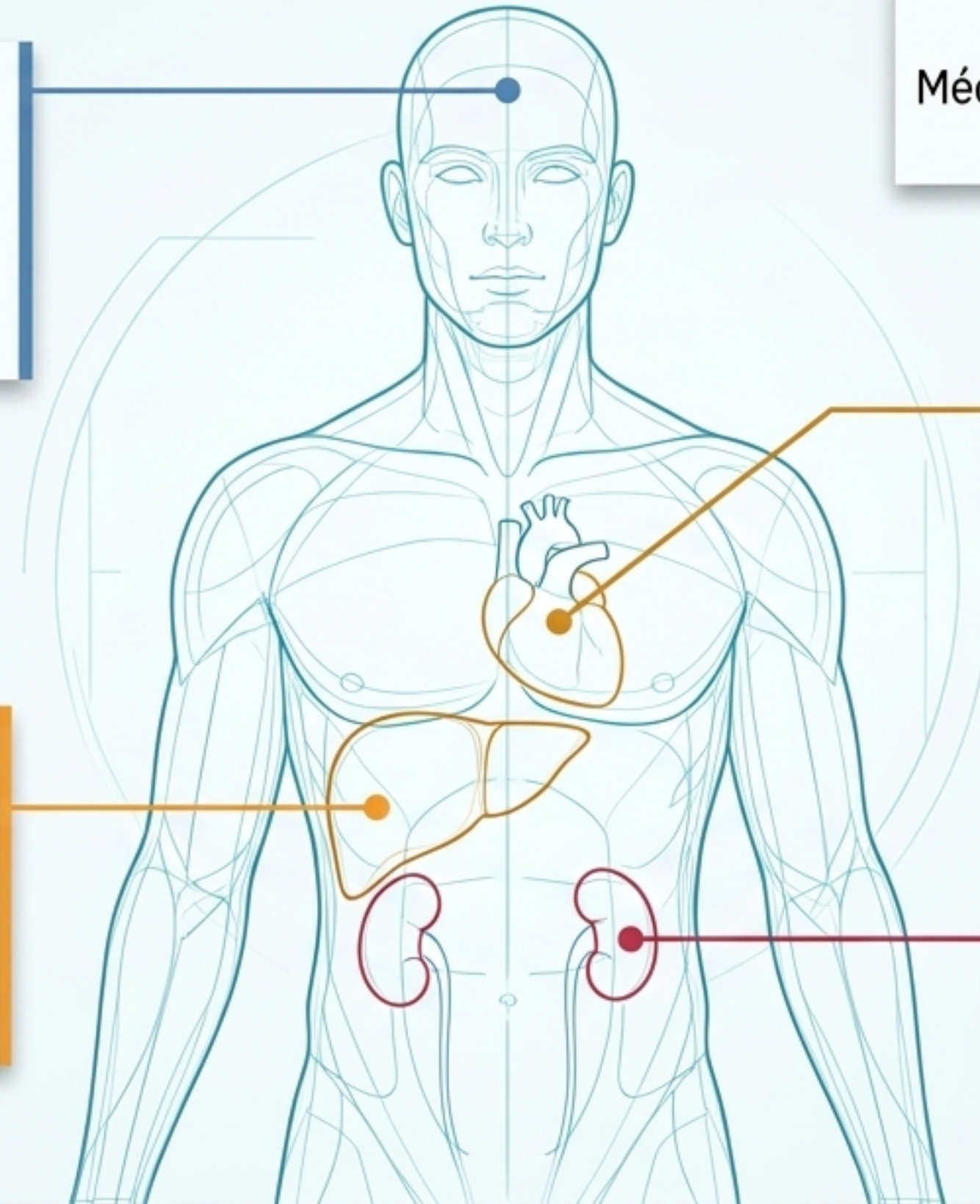
Fígado (Hepatotoxicidade)

Colestase oculta. Monitore GGT.

Colestase oculta. Monitore GGT.
Tríade: NAC + Silimarina + TUDCA
+ Zero Álcool. Orais máx 4-6 sem.

Rins (Filtração)

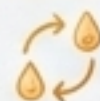
Toxicidade, Rabdomiólise. Falso
positivo Creatinina → Medir Cistatina C.
Hidratação maciça e Astragalus.



Redução de Danos: Mapa Endócrino e Estrutural



Eixo HPT & Fertilidade



- ▲ Supressão profunda (Azoospermia). Criopreservação prévia é essencial.
- ⚠ Intra-ciclo: hCG.
- ▲ TPC: Tamoxifeno/Clomifeno.



Disfunção Sexual



- ▲ Teste alta não garante ereção.
- ⚠ Fatores: Deca-Dick (Prolactina Alta), E2 crashed.
- 📉 Manejo: Tadalafila, Cabergolina.



Controle de Aromatização (E2)

- ▲ Alvo E2: 20-40 pg/mL. Trate sintomas, não números.
- ⚠ IA (Anastrozol/Letrozol) vs. SERM (Tamoxifeno para mamas).



Estrutura & Pele (Glass Cannon)

- ▲ Músculo forte / Tendão fraco (Colágeno I → III).
- Profilaxia: Colágeno II + Vitamina C.
- 🔥 Pele: Finasterida/Espironolactona.



O Escudo Adjuvante: Farmacologia de Proteção (M.1 - M.10)

M.1



1. Hepático

M.2



2. Cardio/Lipídico

M.3



3. Renal

M.4



4. Aromatização

M.5



5. Eixo HPT

M.6



6. Sexual

M.7



7. Neuro

M.8



8. Pele/Cabelo

9.9



9. Virilização ♀

10.10



10. Articular

O Painel de Bordo Final: Rotina, Referência e Filosofia

Frequência Laboratorial



A cada 8-12 semanas:

- Hemograma
- Lipidograma
- Hepático (TGO/TGP/GGT)
- Hormonal
- Cistatina C



Anual (Imagem):

- Ecocardiograma, US Abdominal, MAPA 24h



Apêndice (Quadro Mestre 40+ Moléculas)

Suspensão, Propionato, Enantato, Cipionato, Sustanon, Nebido, Metil-Testo, Bolasterona, Dianabol, Turinabol, Boldenona, DHB, NPP, Deca, Trembolonas (Acetato/Enantato/Hexa), MENT, Mibolerona, Gestrinona, Primobolan, Masteron, Oxandrolona, DHT, Proviron, Superdrol, Hemogenin, Estanozolol, Halotestin

O recurso ergogênico é um turbo, ele potencializa tudo que você fizer de bom, mas também irá piorar tudo que fizer de ruim. É só um instrumento e não substitui um bom protocolo de treino e de dieta, conquanto pode ser seus efeitos colaterais atenuados e seu potencial máximo desbloqueado com os ajustes certos.